DILEMAS BIOÉTICOS

EL DERECHO AL DAÑO AUTOINFLIGIDO

Autonomía, paternalismo y el uso recreacional de las drogas



PULSA ESPACIO PARA EMPEZAR

POR QUÉ ESTE TEMA



UNA DESCONEXIÓN

A un adulto se le permiten riesgos predecibles, como el alcohol o el tabaco, pero no el uso recreacional de drogas.



PATERNALISMO

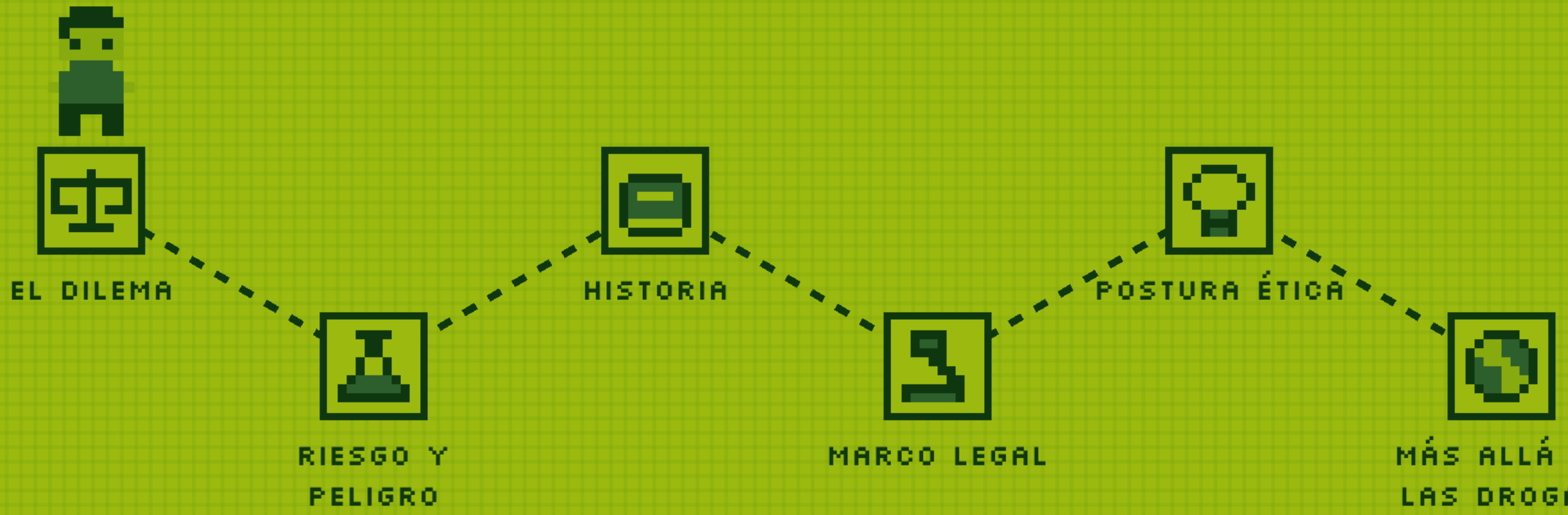
Los Estados restringen decisiones sobre el propio cuerpo a partir de criterios muchas veces arbitrarios.



INGENIERÍA QUÍMICA

La carrera enseña a distinguir riesgo de peligro. La toxicidad depende de la dosis, la pureza, la forma de consumo y la exposición.

Como estudiante de ingeniería química, me parece extraño clasificar un químico como seguro o prohibido sin considerar exposición, concentración, pureza, probabilidad y consecuencia.



CAPÍTULO 1 DE 6

Capítulo 1. El dilema entre autonomía y paternalismo.

RIESGOS QUE UN ADULTO PUEDE ELEGIR

Deportes extremos	PERMITIDO
Tabac	PERMITIDO
Alcoh	PERMITIDO
Dietas	PERMITIDO
Profesiones peligrosas	PERMITIDO
Drogas recreacionales	PROHIBIDO

¿QUÉ DISTINGUE MORALMENTE A LA ÚLTIMA FILA?

Esa desconexión entre el marco ético y el marco legal es el tema de esta presentación.

CONCEPTOS CENTRALES



PATERNALISMO

Aplicar la autoridad, la protección y las decisiones propias de un padre de familia a las relaciones sociales, políticas, laborales o médicas.



AUTONOMÍA

Capacidad de una persona para tomar decisiones libres e informadas sobre su propia vida y su propio cuerpo.



DAÑO AUTOINFLIGIDO

Daño físico, psicológico o social que una persona se causa a sí misma por sus propias decisiones o acciones.

La pregunta es hasta dónde puede el Estado decidir qué riesgos acepta un adulto sobre su propio cuerpo, sobre todo cuando esas decisiones parten de criterios arbitrarios.

CASOS PARA DISCUTIR: ¿INTERVENIR O RESPETAR?

1 Una adulta informada sobre dosis y efectos consume una sustancia en su casa.

2 La misma persona, con la misma dosis, maneja de regreso a casa.

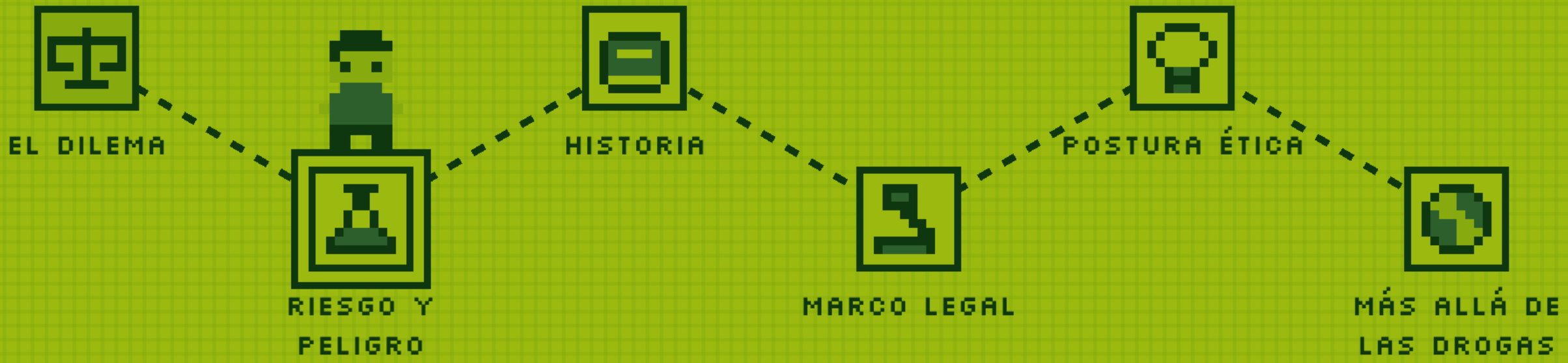
3 Un adulto con años de dependencia quiere dejar de consumir y no lo consigue.

4 Alguien compra una pastilla en una fiesta sin saber qué contiene.

5 Un adulto rechaza por motivos religiosos una transfusión que le salvaría la vida.

6 Una paciente con una enfermedad terminal pide a su médico que la ayude a morir.

Los dos últimos salen del tema de las drogas. Volveremos a ellos al final de la presentación.



CAPÍTULO 2 DE 6

Capítulo 2. Qué son las sustancias psicoactivas, qué riesgos tienen y cómo se reducen.

CLASES DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS



DEPRESIVOS

Ralentizan el sistema nervioso central.

Alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos



ESTIMULANTES

Aceleran el sistema nervioso central.

Cafeína, cocaína, anfetaminas



ALUCINÓGENOS

Distorsionan la percepción.

LSD y otros psicodélicos

???

SIN CLASE CLARA

Disociativos y empatógenos.

Ketamina, MDMA

Disociativos y empatógenos no encajan claramente en ninguna, así que la división funciona como clasificación general.

PERCEPCIÓN SOCIAL POR SUSTANCIA

COCAÍNA
OPIOIDES
MDMA
ANFETAMINAS
PSICODÉLICOS
BENZODIAZEPINAS
BARBITÚRICOS
CAFEÍNA
ALCOHOL
TABACO
CANNABIS
HACHÍS

USO COTIDIANO
ESTIGMA MARCADO

Las sustancias con más restricciones legales cargan un estigma social mucho más marcado.

FACTORES DEL CONSUMO (MODELO BIOPSICOSOCIAL)

BIOLÓGICOS

Condiciones genéticas
Envejecimiento
Automedicación

PSICOLÓGICOS

Tipo de personalidad
Depresión
Curiosidad y aburrimiento

SOCIALES

Pertenencia a un grupo
Rebeldía
Situación socioeconómica

MARTIN A. PLANT **AMISTAD** **PLACER** **ESTATUS** **SUBCULTURA**

Según Martin A. Plant, el consumo puede formar parte de una subcultura asociada con estatus, amistad y placer. Para el propio usuario puede ser una afirmación positiva más que una experiencia negativa.

PELIGRO Y RIESGO



PELIGRO
Fuente, situación o acto con potencial de causar daño.



RIESGO
Probabilidad de que ese peligro se materialice.

DOSIS
ADULTERANTES
VÍA DE CONSUMO
FRECUENCIA
INTERACCIONES

RIESGO

PELIGRO: SIN CAMBIO

Este es el criterio de la ingeniería química: evaluar cuánto riesgo implica una sustancia y en qué condiciones, en lugar de clasificarla como segura o prohibida.

DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO



AL USUARIO

Adictividad

Daño físico

Efectos a corto y largo plazo



A TERCEROS

Accidentes vehiculares

Altercados violentos

Violencia doméstica

El dilema de esta presentación está en la primera columna. El daño a terceros se justifica con otro argumento.

ADICCIÓN Y CAPACIDAD DE DECISIÓN

CAPACIDAD DE DECISIÓN

Habilidad para comprender información, evaluar consecuencias y tomar una decisión razonada.

ADICCIÓN

Dificultad persistente para controlar el consumo de una sustancia a pesar de sus consecuencias negativas.

La adicción puede reducir la capacidad de decisión. Una decisión que fue autónoma al inicio puede terminar limitando la autonomía futura.

REDUCCIÓN DE DAÑOS Y USO RESPONSABLE


Educación sobre efectos y riesgos

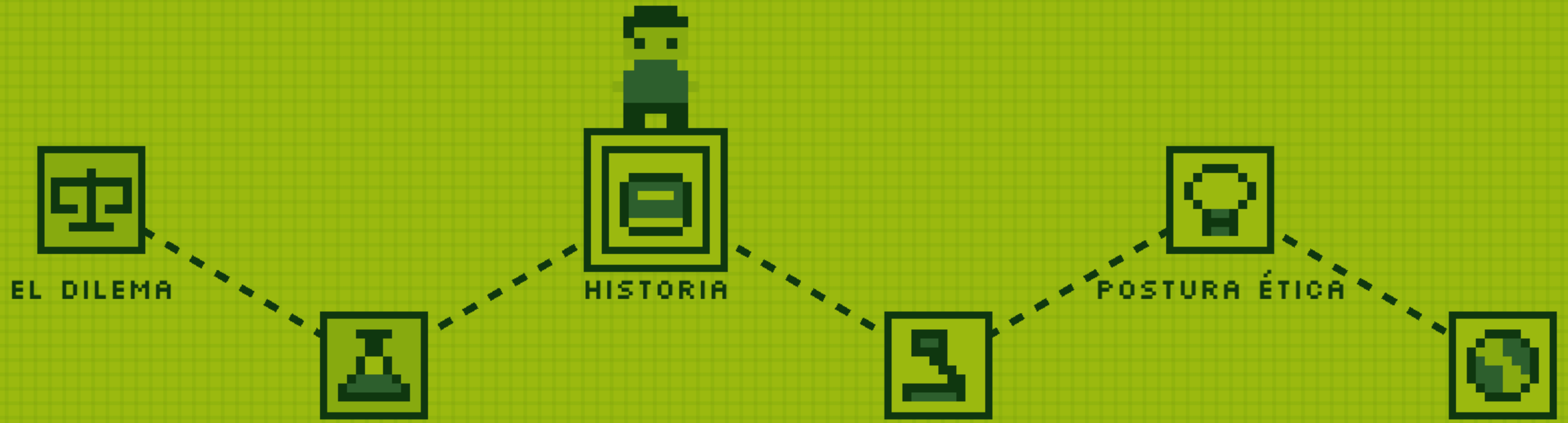

Información sobre dosis e interacciones


Análisis de sustancias


Prevención de enfermedades


Sobriedad para conducir, nadar u operar maquinaria

El uso responsable pide abstenerse en actividades peligrosas sin sobriedad. Ambos enfoques aceptan la autonomía del usuario y se apoyan en el consentimiento informado.



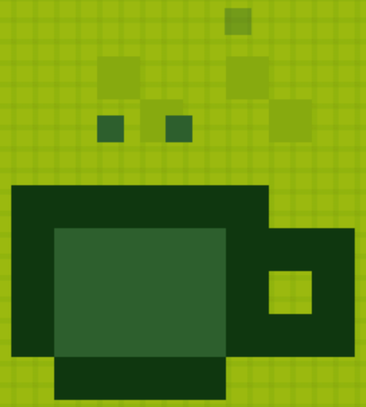
CAPÍTULO 3 DE 6

Capítulo 3. Antecedentes históricos de la prohibición.

IMPERIO OTOMANO, SIGLO XVII



MURAD IV



HOY: USO COTIDIANO

CAFETERÍAS
Lugares de reunión y discusión política, vistos con sospecha.

La prohibición no fue permanente. Una sustancia que hoy es completamente normal llegó a prohibirse por el contexto cultural y político de su época.



SAN FRANCISCO, 1875

«Muchas mujeres y mujeres jóvenes, al igual que hombres jóvenes de familias respetables, estaban siendo persuadidas a visitar antros de opio, donde estaban siendo arruinados moralmente y de otras maneras».



Fumar opio, práctica asociada a inmigrantes chinos — RESTRINGIDO



Preparados medicinales de opio de otros sectores — OTRO TRATO

La medida apuntaba a una práctica asociada con los inmigrantes chinos. Los preparados medicinales de opio, usados por otros sectores, no recibieron necesariamente el mismo trato.

CONTROL INTERNACIONAL, 1909–1988





1909

SHANGHÁI

Comisión Internacional del Opio



1912

LA HAYA

Primer tratado vinculante. Suma morfina y cocaína



1914

EE. UU.

Harrison Act: registro e impuestos



1920

REINO UNIDO

Dangerous Drugs Act



1961

ONU

Convención Única sobre Estupefacientes



1971-88

ONU

Psicotrópicos y tráfico ilícito

Se pasó de prohibiciones locales a un sistema internacional, aunque cada país conserva diferencias importantes en su trato al consumidor.

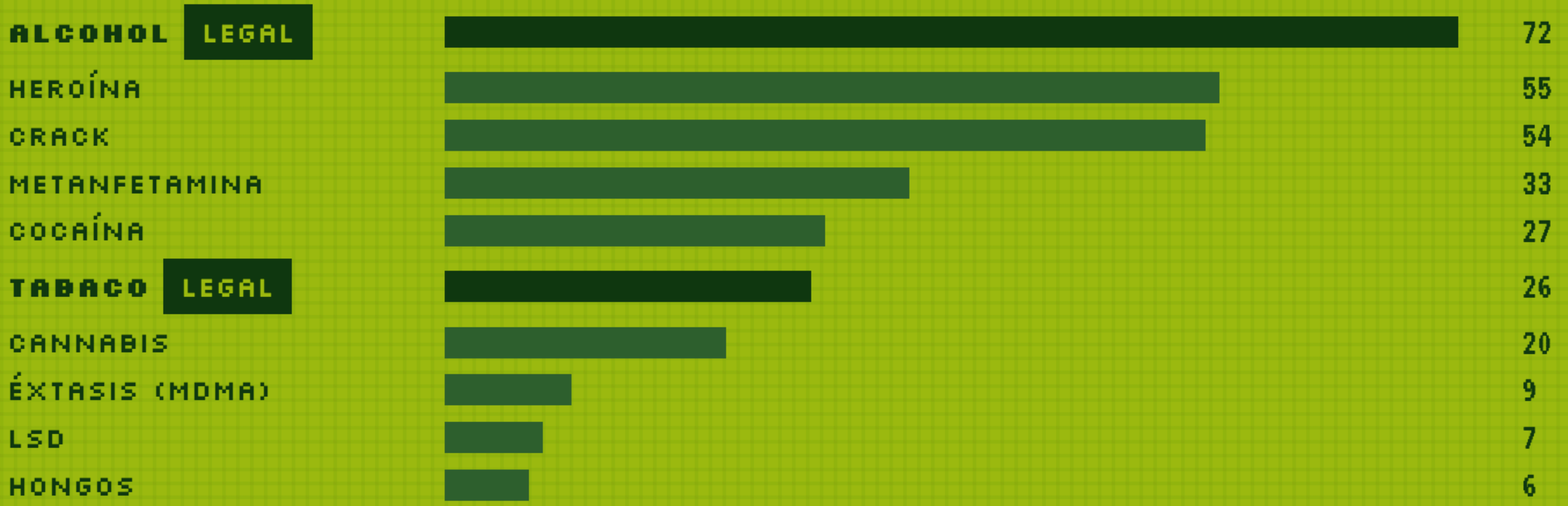
RAZONES CITADAS PARA PROHIBIR

Café, Imperio Otomano, siglo XVII	POLÍTICA
Opio fumado, San Francisco, 1875	MORAL
Harrison Act, Estados Unidos, 1914	FISCAL
Cocaína y opiáceos, Reino Unido, 1916	MILITAR

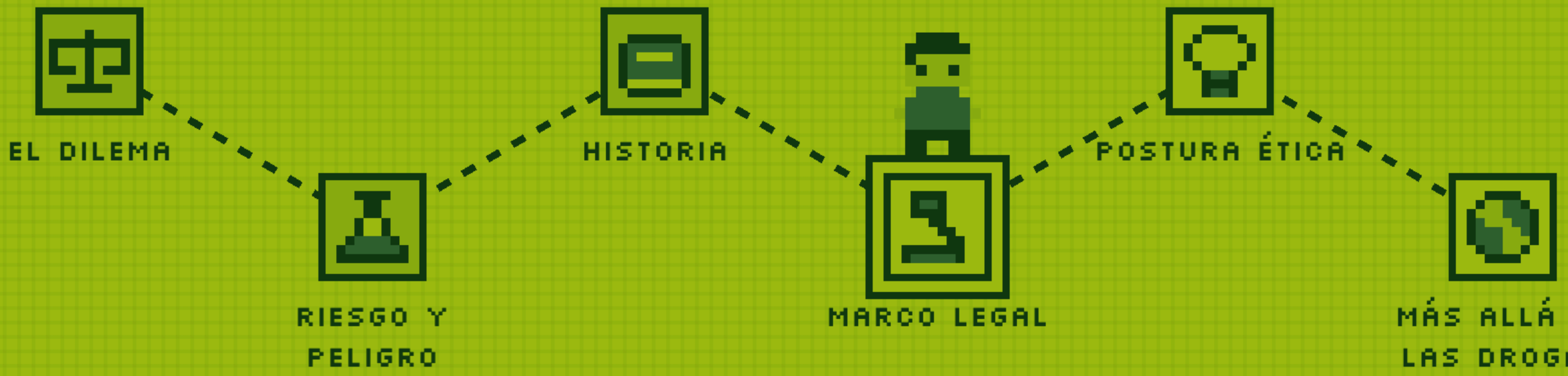
En ninguno de estos casos la razón principal fue una evaluación del riesgo de cada sustancia.

Las clasificaciones que nacieron así se heredaron después por inercia moral, más que por nueva evidencia científica.

DAÑO TOTAL, DE 0 A 100 (NUTT ET AL., 2010)



El alcohol obtuvo el puntaje más alto, y el tabaco quedó junto a la cocaína. Los autores concluyeron que la clasificación legal británica prácticamente no se relaciona con el daño medido.



CAPÍTULO 4 DE 6

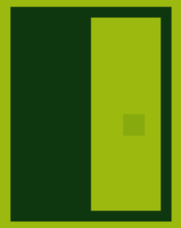
Capítulo 4. Marco legal actual en México y en otros países.

TRES FIGURAS LEGALES



PROHIBICIÓN

La ley impide producir, poseer, vender o consumir, con sanción penal.



DESPENALIZACIÓN

Se elimina o reduce la sanción penal de una conducta, sin volverla completamente legal.



LEGALIZACIÓN

La actividad se permite dentro de un marco de reglas y controles.

Un país puede despenalizar el consumo personal y mantener completamente prohibidas la producción y la venta.



LEY GENERAL DE SALUD

ARTÍCULO 478

Sin acción penal contra el consumidor que posea cantidades iguales o menores a la tabla, para estricto consumo personal.

TABLA DEL ARTÍCULO 479

- CANNABIS
- COCAÍNA
- HEROÍNA
- OPIO
- LSD
- MDMA
- METANFETAMINA

MERCADO LEGAL

INEXISTENTE

Producir, transportar, comerciar y suministrar sin autorización sigue prohibido.

Ninguna de estas sustancias es legal. El Estado reconoce al consumidor y le fija una cantidad, sin ofrecerle una forma legal de obtenerla.



CANNABIS Y LA SUPREMA CORTE

2015

La Corte empieza a resolver casos de autoconsumo recreativo.

2021

Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. COFEPRIS debe autorizar a personas adultas.



FUNDAMENTO

Derecho al libre desarrollo de la personalidad.

LÍMITES

- SIN VENTA
- SIN AFECTAR A TERCEROS
- LEJOS DE MENORES
- SIN CONDUCIR

La autorización no crea un mercado ni permite afectar a terceros. La Corte usó la autonomía como fundamento y el daño a terceros como límite.

MODELOS DE REGULACIÓN POR PAÍS



VIGENTE

MÉXICO

Posesión mínima sin acción penal. Autoconsumo de cannabis con autorización.



2001

PORTUGAL

Posesión para consumo personal por la vía administrativa.



2013

URUGUAY

Ley 19.172. Acceso regulado al cannabis para adultos.

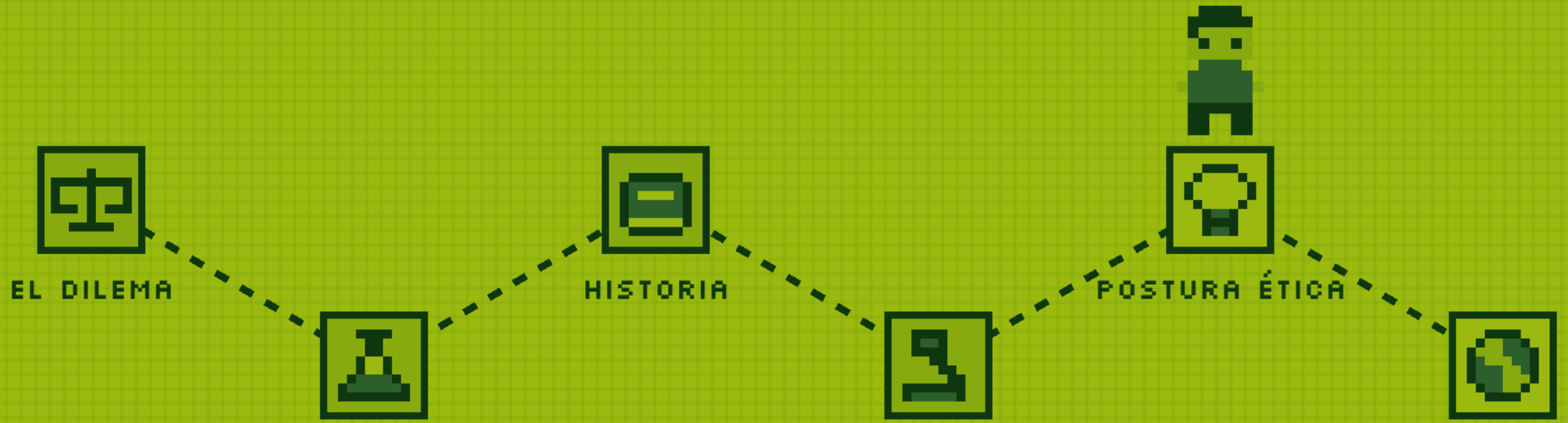


2018

CANADÁ

Cannabis Act. Mercado legal regulado para adultos.

La clasificación legal ha cambiado con el contexto histórico, social y político. Varios países vuelven a separar el consumo personal, el tráfico y la producción regulada.



CAPÍTULO 5 DE 6

Capítulo 5. Postura ética.

TESIS

La existencia de un riesgo para la salud no es por sí sola una justificación ética suficiente para eliminar la autonomía de una persona adulta.



1 SALUD



2 CONSENTIMIENTO



3 TERCEROS



4 ADICCIÓN



5 PROHIBICIÓN

La postura se desarrolla en cinco puntos.

1. EL ARGUMENTO DE SALUD



EL ARGUMENTO MÁS LEGÍTIMO

El consumo pone en riesgo la salud del usuario, y eso basta para que el Estado lo prohíba.



LO QUE MUESTRA LA HISTORIA

Las prohibiciones respondieron a razones políticas, morales, fiscales y militares, no a la reducción de daños.



CONSISTENCIA

Deportes extremos, tabaco y alcohol también dañan a quien los elige, y están permitidos.

Además, la sociedad ya acepta riesgos comparables cuando la decisión es voluntaria e informada. El riesgo para la salud, por sí solo, no distingue a las drogas.

2. CONSENTIMIENTO INFORMADO



CONSENTIMIENTO INFORMADO

Decisión voluntaria tomada después de recibir y comprender información suficiente sobre los riesgos y consecuencias.



CAPACIDAD DE DECISIÓN

Habilidad para comprender información, evaluar consecuencias y tomar una decisión razonada.



La intervención está más justificada cuando la persona no tiene capacidad suficiente o desconoce lo que está consumiendo.

Cuando falta alguna de las dos, la decisión deja de ser plenamente autónoma.

3. DAÑO A TERCEROS



PROTEGE A TERCEROS

Impedir que alguien conduzca bajo los efectos de una sustancia o venda drogas a menores.



DECIDE SOBRE EL PROPIO CUERPO

Impedir que un adulto consuma una sustancia únicamente porque puede causarse daño a sí mismo.



PRINCIPIO DE DAÑO · J. S. MILL

Limitar la libertad de una persona solo se justifica para evitar daño a terceros.

En la segunda decide qué nivel de riesgo puede aceptar una persona sobre su propio cuerpo. El principio de daño de Mill traza esa línea.

4. ADICCIÓN



EL PROBLEMA

Algunas sustancias alteran progresivamente la capacidad de controlar el consumo. Una decisión autónoma puede terminar reduciendo la autonomía futura.

ALTERNATIVAS A LA PROHIBICIÓN TOTAL



Educación



Tratamiento de las adicciones



Control de calidad



Regulación



Reducción de daños

Puede justificar ciertos tipos de intervención, pero la prohibición total no es la única manera de proteger a estas personas.

5. DAÑOS DE LA PROHIBICIÓN

EFECTOS DE LA PROHIBICIÓN

- Producción y venta en mercados ilegales
- Sin control de pureza, concentración o calidad
- Disputas sin instituciones legales para resolverlas

BENEFICENCIA Y NO MALEFICENCIA

Una política se evalúa por el daño de la sustancia y también por el daño que produce la manera de regularla.

Bajo los principios de beneficencia y no maleficencia, se considera el daño de la sustancia y también el de la forma en que se regula.

OBJECIÓN: EL DAÑO NUNCA ES SOLO PROPIO



LA OBJECIÓN

El daño autoinfligido rara vez afecta solo a quien lo elige. Sus costos alcanzan a la familia y al sistema de salud.



RESPUESTA

Los mismos costos indirectos existen con el alcohol, el tabaco y los deportes extremos, y la ley los permite.



Cuando el daño a otros es directo, como conducir bajo los efectos de una sustancia, ya se cumple la condición de daño a terceros.

Si los costos indirectos bastaran para prohibir, también justificarían prohibir el alcohol, el tabaco y muchas otras prácticas que la ley permite.

CONDICIONES QUE JUSTIFICAN INTERVENIR



La persona no tiene capacidad suficiente para decidir



Desconoce lo que está consumiendo



Una adicción limita seriamente su capacidad de decisión



El consumo genera un riesgo considerable para otras personas



Cuando un adulto competente conoce los riesgos y decide asumirlos, la prohibición necesita una justificación ética mayor que el daño a sí mismo.

Fuera de ellas, el daño recae principalmente sobre quien toma la decisión.

REGULACIÓN SEGÚN EL RIESGO



PROPUESTA

Analizar el consumo recreativo según el riesgo real de cada sustancia y cada situación, en lugar de aplicar el mismo nivel de intervención a toda droga ilegal.



PROTEGER A TERCEROS



INFORMAR AL USUARIO

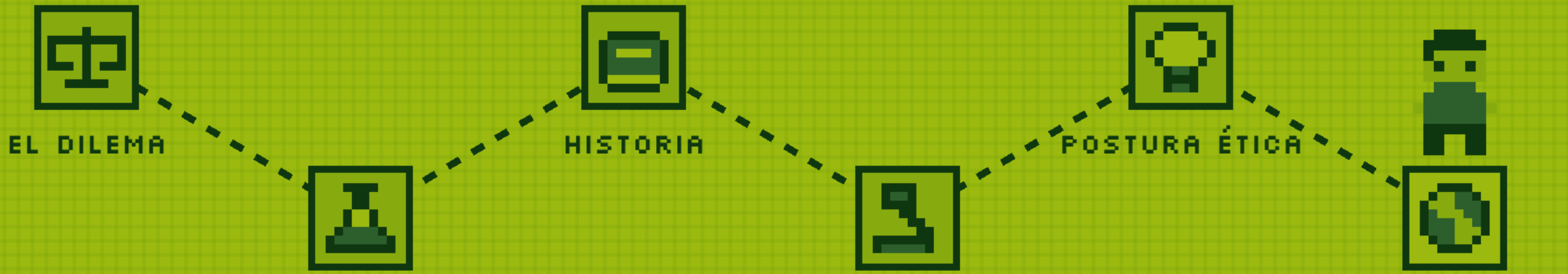


TRATAR LA ADICCIÓN



CONTROLAR LA CALIDAD

La autonomía no es un derecho absoluto, pero el Estado necesita una razón suficientemente fuerte para intervenir en decisiones cuyo daño recae sobre quien las toma.



CAPÍTULO 6 DE 6

Capítulo 6. El mismo dilema fuera de las drogas.

PATERNALISMO EN LA VIDA COTIDIANA

Cinturón de seguridad obligatorio	OBLIGA
Casco obligatorio en motocicleta	OBLIGA
Medicamentos que requieren receta	RESTRINGE
Etiquetado frontal de advertencia	DESALIENTA
Impuestos al tabaco y a bebidas azucaradas	DESALIENTA
Rechazo de tratamiento médico	PERMITIDO
Eutanasia y suicidio asistido	PROHIBIDO

En la medicina el dilema aparece en su forma más clara, porque la decisión sobre el propio cuerpo puede terminar en la muerte.

RECHAZO DE TRATAMIENTO MÉDICO

EL CASO

Un adulto competente rechaza una transfusión por motivos religiosos, o un paciente decide no recibir quimioterapia.

MARCO LEGAL

La Ley General de Salud reconoce el derecho a aceptar o rechazar los tratamientos propuestos. Un enfermo terminal puede suspender el tratamiento curativo y dejar una voluntad anticipada.

Si un adulto puede rechazar un tratamiento que le salvaría la vida, falta explicar por qué no puede asumir el riesgo de consumir una sustancia.

El consentimiento informado protege tanto el derecho a aceptar como el derecho a rechazar.

EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO

EUTANASIA

Un médico termina la vida de un paciente que lo solicita, para evitarle un sufrimiento que considera intolerable.

SUICIDIO ASISTIDO

El médico proporciona los medios y el propio paciente realiza el acto final.

Es la forma más extrema del dilema. El daño autoinfligido es irreversible, y la autonomía choca directamente con la protección de la vida.

Los países que la permiten exigen condiciones parecidas a las de esta postura: adultos capaces, una decisión informada y reiterada, y la confirmación de más de un médico.

EUTANASIA EN EL MUNDO



1997

COLOMBIA



2002

PAÍSES BAJOS



2002

BÉLGICA



2016

CANADÁ



2021

ESPAÑA



2024

ECUADOR



2025

URUGUAY



SOLO ASISTIDO

SUIZA



PROHIBIDA

MÉXICO

Suiza solo permite el suicidio asistido. En México la Ley General de Salud prohíbe la eutanasia y el suicidio asistido, aunque varias iniciativas buscan derogar esa prohibición.

GRAVEDAD DEL DAÑO Y TRATO LEGAL



DROGAS RECREATIVAS

Riesgo variable

POSESIÓN TOLERADA



RECHAZO DE TRATAMIENTO

Puede causar la muerte

DERECHO RECONOCIDO



EUTANASIA

Causa la muerte

PROHIBIDA

MENOR GRAVEDAD

MAYOR GRAVEDAD

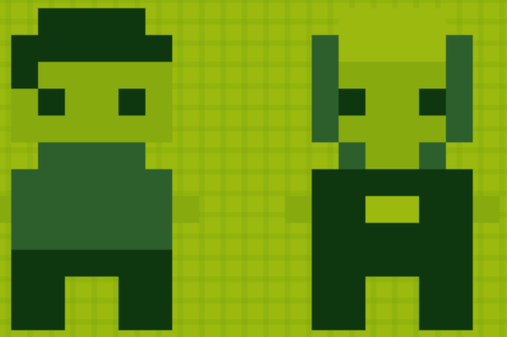
Rechazar un tratamiento que puede causar la muerte es un derecho, mientras que consumir una sustancia de riesgo variable no tiene un mercado legal.

EL CONFLICTO BIOÉTICO

Hasta qué punto tenemos derecho a impedir que otra persona tome una decisión que consideramos dañina, cuando las principales consecuencias de esa decisión recaen sobre ella misma.

El conflicto no está en decidir si las drogas, el rechazo de un tratamiento o la eutanasia son buenos o malos, sino en determinar hasta dónde llega nuestro derecho a decidir por otros.

GRACIAS



FUENTES

J. S. Mill, *On Liberty* (1859) · M. A. Plant, investigación sobre adicción

Ley General de Salud, artículos 478 y 479 · Código Penal Federal

SCJN, Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018

Convenciones de la ONU de 1961, 1971 y 1988

Ley General de Salud, artículos 51 Bis 2, 166 Bis 5 y 166 Bis 21

TEDH, Pindo Mulla c. España (2024) · Nutt, King y Phillips, *The Lancet* (2010)